

奥美拉唑药物相互作用案例分析

刘 雄

广东省梅州市人民医院药剂科, 广东梅州 514100

[摘要] 目的 探讨奥美拉唑与其他药物同时运用时的相互作用。方法 通过本院消化内科在选用奥美拉唑配合其他不同的药物治疗时产生的相互作用 6 例案例进行分析总结。结果 奥美拉唑抑制药效的药物有硫酸亚铁片、地高辛、酮康唑, 有强化药效作用的是华法林、卡马西平、甲氨蝶呤。结论 奥美拉唑与其他药物合用时, 配伍前应了解药物的生化及代谢过程。以免产生药物间相互作用, 降低药效或产生毒副作用, 影响治疗效果。

[关键词] 奥美拉唑; 药物; 相互作用; 案例分析

[中图分类号] R975

[文献标识码] B

[文章编号] 1674-4721(2012)08(b)-0255-02

Case analysis of drug interactions in Omeprazole

LIU Xiong

Department of Pharmacy, the People's Hospital of Meizhou City in Guangdong Province, Meizhou 514100, China

[Abstract] **Objective** To explore the interaction of Omeprazole and other drugs for use at the same time. **Methods** Six cases with the interaction caused by using Omeprazole combined with other different drugs in Digestion medical department of our hospital were analyzed and summarized. **Results** Omeprazole could inhibit the efficacy of the drug including Ferrous sulfate tablets, Digoxin, Ketoconazole, and could strengthen the efficacy of the drug including warfarin, Carbamazepine, Methotrexate. **Conclusion** The use of Omeprazole combined with other drugs before should be aware of the drug's biochemical and metabolic processes, in order to avoid the drug interactions, reduce efficacy, occur side effects and influence the therapeutic effects.

[Key words] Omeprazole; Drugs; Interaction; Case analysis

奥美拉唑为质子泵抑制剂, 可以有效地抑制胃酸分泌, 是临床上治疗消化性溃疡的首选药物^[1-2]。但是许多患者多种病变情况并存, 需要同时服用多种药物。奥美拉唑与其他药物同时服用时, 与部分药物是有相互作用的, 多表现为抑制作用或强化作用, 而且容易出现许多不良反应, 严重影响药物的效果与患者的治疗^[3]。本研究就本院消化内科采用奥美拉唑治疗消化性溃疡的同时, 服用其他药物出现相互作用案例进行分析总结, 并提出防范措施。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾本院消化内科在治疗消化性溃疡患者合并其病变时选用奥美拉唑配合其他不同的药物产生的相互作用 6 例, 年龄 38~68 岁, 其中, 男性 3 例, 女性 3 例, 合并病变分别为贫血、心肌梗死、心功能不全、霉菌性阴道炎、癫痫、乳腺癌。配合服用的药物分别为硫酸亚铁片、华法林、地高辛、酮康唑、卡马西平、甲氨蝶呤片。

1.2 方法

观察药物配合服用后的作用影响, 及时修改处方, 总结分析出现相互作用的原因, 提出修改建议。具体如下:

1.2.1 胃溃疡与贫血合并

1.2.1.1 案例简介 患者, 男, 50 岁, 胃溃疡合并贫血, 医生处方为: 奥美拉唑肠溶胶囊 20 mg/次, 3 次/d, 硫酸亚铁片 1 片/次, 3 次/d。连续服用 20 d 后复查贫血情况无好转。医生及时修改处方, 奥美拉唑肠溶胶囊配合阿胶口服液 10 mL/次, 2 次/d。14 d 后观察血红蛋白明显回升。

1.2.1.2 原因分析 奥美拉唑是通过抑制质子泵从而达到抑制胃酸分泌的目的, 而硫酸亚铁中的铁离子是在酸性环境下使 Fe^{3+} 转变为可吸收的 Fe^{2+} , 补充到血液中, 使血红蛋白增高, 奥美拉唑的抑酸对硫酸亚铁的需酸形成了抑制作用。

1.2.1.3 药师建议 在服用奥美拉唑的时候, 如果合并贫血的情况最好是避免与铁剂同时服用, 改用其他治疗贫血的药物。

1.2.2 胃溃疡与心肌梗死合并

1.2.2.1 案例简介 患者, 男, 52 岁, 胃溃疡合并心肌梗死, 医生处方为: 奥美拉唑肠溶胶囊 20 mg/次, 3 次/d, 华法林 10 mg/d, 连服 3 d 后出现下肢出血点, 血常规显示血小板下降, 有出血倾向, 医生修改处方, 将华法林用量改为 7.5 mg/d, 情况好转。

1.2.2.2 原因分析 华法林属于肝药酶代谢药物, 奥美拉唑具有酶抑制作用, 抑制肝药酶对华法林的代谢, 使华法林体内聚集, 半衰期延长, 血药浓度增高, 作用增强。奥美拉唑对华法林具有强化作用。

1.2.2.3 药师建议 在奥美拉唑与华法林同时服用的时候适当减少华法林的服用剂量, 考虑到奥美拉唑对华法林的强化作用, 严密观察出血倾向, 定期检查血常规。

1.2.3 十二指肠溃疡与心功能不全合并

1.2.3.1 案例简介 患者, 男, 68 岁, 十二指肠溃疡合并心功能不全, 医生处方为: 奥美拉唑肠溶胶囊 20 mg/次, 3 次/d, 地高辛片 0.25 mg/次, 1 次/d。服用 3 d 后呼吸困难、水肿情况加重, 医生修改处方, 将地高辛的用量增加至 0.375 mg/次, 1 次/d,

情况好转。

1.2.3.2 原因分析 奥美拉唑的抑酸作用抑制地高辛的分解过程,使地高辛的有效浓度降低,作用减弱,奥美拉唑对地高辛具有抑制作用。

1.2.3.3 药师建议 在奥美拉唑与地高辛同时服用的时候,应适当加大地高辛的服用剂量,或是在服用地高辛 2 h 后再考虑服用奥美拉唑。

1.2.4 胃溃疡与霉菌性阴道炎合并

1.2.4.1 案例简介 患者,女,38 岁,胃溃疡合并霉菌性阴道炎,医生处方为奥美拉唑肠溶胶囊 20 mg/次,3 次/d,酮康唑片 0.2 g/次,2 次/d,复方黄柏液外用 2 次/d,连续运用 3 个疗程后(7 d 为 1 个疗程),复查霉菌由+变为+++ ,病情加重。医生修改处方,将奥美拉唑改为西咪替丁片 0.2 g/次,3 次/d。3 个疗程后复查霉菌为阴性。

1.2.4.2 原因分析 酮康唑的吸收依赖于酸性环境,与奥美拉唑的抑酸作用形成矛盾,奥美拉唑对酮康唑具有抑制作用。

1.2.4.3 药师建议 在服用酮康唑的时候最好是避免与奥美拉唑配伍,或是隔开 2 h 服用,避免相互影响。

1.2.5 十二指肠溃疡与癫痫合并

1.2.5.1 案例简介 患者,女,50 岁,十二指肠溃疡合并癫痫,医生处方为:奥美拉唑肠溶胶囊 20 mg/次,3 次/d,卡马西平片 0.2 g/次,2 次/d。服用 5 d 后患者的躁狂症状加重,医生修改处方,将卡马西平片用量改为 0.1 g/次,2 次/d。情况好转。

1.2.5.2 原因分析 奥美拉唑具有酶抑制作用,抑制肝药酶对卡马西平的代谢,使卡马西平体内聚集,半衰期延长,血药浓度增高,作用增强。奥美拉唑对卡马西平具有强化作用。

1.2.5.3 药师建议 奥美拉唑与卡马西平同时运用的时候,最好是在卡马西平服用 2 h 后再服用奥美拉唑,使两种药物都可以充分发挥作用。

1.2.6 胃溃疡与乳腺癌合并

1.2.6.1 案例简介 患者,女,48 岁,胃溃疡合并乳腺癌。医生处方为:奥美拉唑肠溶胶囊 20 mg/次,3 次/d,甲氨蝶呤片 10 mg/d,1 次/周,运用药物后检查甲氨蝶呤的药物浓度持续升高,下降缓慢,不符合甲氨蝶呤的代谢原理。医生修改处方,将奥美拉唑改为雷尼替丁胶囊 0.15 g/次,3 次/d,情况好转。

1.2.6.2 原因分析 甲氨蝶呤的代谢主要是通过血液中的 H⁺,而奥美拉唑的质子泵抑制作用抑制氢泵,使甲氨蝶呤的血液浓度持续增高,下降缓慢,引起药物毒性,奥美拉唑对甲

氨蝶呤有强化作用。

2 结果

观察分析 6 例案例在奥美拉唑配合其他药物治疗时出现的相互作用,总结为两点:一是抑制作用,二是强化作用。详细情况见表 1。

表 1 奥美拉唑对配伍药物的作用及处理对策

项目	硫酸亚铁片	华法林	地高辛	酮康唑	卡马西平	甲氨蝶呤片
作用	抑制	强化	抑制	抑制	强化	强化
处理	换药	减量	加量	分时间服用	分时间服用	换药

3 讨论

奥美拉唑为临床上治疗消化性溃疡首选的药物,但是如果与合并其他病变治疗药物同时配伍运用的话,容易出现许多相互作用^[4-5],抑制药物的效果或强化药物的效果,影响正常的治疗。

本组研究中发现对硫酸亚铁片、地高辛、酮康唑有明显抑制作用,降低药物疗效。对华法林、卡马西平、甲氨蝶呤片配伍,可以增强这些药物的药效,甚至产生中毒反应,引发危险。故提示在配伍前应详细了解药物的生化代谢过程。如有相互禁忌应换药或隔开服用时间来解除或避免药物之间的相互作用,避免影响患者的治疗效果,达到有效的治疗目的。

综上,奥美拉唑与其他药物合用时,应详细阅读其他药物说明书或进一步了解药物的药理过程^[6]。避免由于用药不当,出现降低药效、中毒反应等。不但影响正常治疗效果,且容易引发危险,甚至死亡。

[参考文献]

[1] 熊邦定,周鹏. 奥美拉唑、阿莫西林、替硝唑联合治疗幽门螺杆菌阳性消化性溃疡的疗效观察[J]. 中国卫生产业, 2011, 8(12X):40.
[2] 潘跃章. 奥美拉唑与法莫替丁治疗消化性溃疡的疗效分析[J]. 临床合理用药杂志, 2011, 4(12X):52.
[3] 南君. 雷贝拉唑联合奥美拉唑治疗消化性溃疡疗效和安全性评价[J]. 中国现代药物应用, 2011, 5(24):3-4.
[4] 曲彩红,黎小妍. 伏立康唑与奥美拉唑可能的不良相互作用致肌病及肝功能恶化[J]. 药物不良反应杂志, 2011, 13(6):374-377.
[5] 李静丽. 奥美拉唑治疗消化性溃疡 28 例临床观察[J]. 中国医药科学, 2011, 1(24):88.
[6] 于伟凡. 双黄连注射液对奥美拉唑代谢的影响[J]. 中国医药导刊, 2011, 13(1):114-115.

(收稿日期:2012-05-10 本文编辑:林利利)

(上接第 254 页)

[参考文献]

[1] 王继生,李玉新. 单侧多功能外固定架治疗胫腓骨骨折[J]. 中医正骨, 2008, 20(5):58.
[2] 张文昌. 单边外固定架治疗胫腓骨骨折[J]. 实用骨科杂志, 2011, 17(12):1137-1139.
[3] 黄小刚. 交锁髓内钉和单侧外固定架治疗胫腓骨骨折的比较[J]. 现代中西医结合杂志, 2008, 17(18):2847-2847.
[4] Reynders P. Open acute segmental tibial fracture fixation using the Less

Invasive Stabilisation System (LISS): study of 23 consecutive cases[J]. Injury, 2009, 40(4):449-454.
[5] Ping Liu, Zuo Wei, You Xiuwei, et al. Treatment of children's shaft fracture of Tibia and Fibula with ESIN Fixation[J]. Open Journal of Pediatrics, 2011, 1(2):9-11.
[6] 刘刚,任先军,蔡荣林,等. 胫腓骨骨折治疗回顾与分析[J]. 中国医学创新, 2010, 7(2):96-98.

(收稿日期:2012-04-25 本文编辑:袁成)